

Hyperthyreose Dr Heiko mit Dr Nurettin 01.05.2026

-Verdacht mit Reiseanamnese Thailand - Patientenvorstellung und Heikos Feedback

Patienteninformationen

- **Name:** Patricia Gerber (P-A-T-R-I-Z-I-A G-E-R-B-E-R)
- **Alter:** 46 Jahre
- **Geburtsdatum:** 3. März 1980
- **Größe:** 1,72 m
- **Gewicht:** 61 kg (Gewichtsverlust von 5 kg in den letzten 3 Wochen)
- **Beruf:** Busfahrerin

Aktuelle Beschwerden

Hauptsymptome (seit 3 Wochen)

- **Schlafstörungen:** Sowohl Einschlaf- als auch Durchschlafstörungen
- **Starkes Schwitzen (Hyperhydrosis)**
- **Nervosität und innere Unruhe:** Familie bemerkt erhöhte Reizbarkeit
- **Konzentrationsstörungen**
- **Tachykardie:** Puls normalerweise 70-80/min, aktuell 90-100/min
- **Wässriger Durchfall:** 3-5x täglich (seit etwa 3 Wochen), hell, schleimig, nicht blutig
- **Gewichtsverlust:** 5 kg in 3 Wochen trotz gutem Appetit
- **Subfebril bis febrile Temperaturen:** Fast 38°C (abends gemessen), normalerweise 36,8-37°C

Verneinte Symptome

- Keine Atemnot
- Keine Bauchkrämpfe oder Bauchschmerzen
- Kein Schüttelfrost
- Keine Halsschmerzen oder Schnupfen
- Kein bemerkter Haarausfall (nicht mehr als gewöhnlich)
- Keine bemerkte Struma oder Schwellung am Hals
- Keine Zitterigkeit (Tremor) bisher aufgefallen

Vorerkrankungen

- **Hypothyreose:** Seit 10 Jahren diagnostiziert, unter L-Thyroxin 75 µg (1x morgens) gut eingestellt, letzte Kontrolle vor einem Jahr
- **Allergisches Asthma:** Allergisch auf Hausstaubmilben und Pollen (aktuell Birke und Erle), nimmt Viani-Spray 2x täglich (Cortison-haltig)

Operative Eingriffe

1. Mit 11 Jahren: Appendektomie
2. Vor 28 Jahren: Sectio caesarea (Kaiserschnitt)
3. Vor 2 Jahren: Karpaltunnelsyndrom links operiert (Nerv war eingeklemmt, Kribbeln in den Fingern)

Reiseanamnese

Wichtig: Patientin war vor 2 Monaten für 2 Wochen in **Thailand**. Vor der Reise wurden notwendige Impfungen durchgeführt, jedoch wurde **keine Malariaprophylaxe** betrieben.

Urologische Voruntersuchung

- Vor 6 Wochen: Gynäkologin überwies zur urologischen Nierenuntersuchung wegen Beschwerden beim Wasserlassen
- Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittel (wahrscheinlich i.v.-Pyelogramm) durchgeführt
- Patientin vertrug das Kontrastmittel nicht gut (Übelkeit, einmaliges Erbrechen)
- Befund: Unauffällig

Anmerkung: Kontrastmittel für i.v.-Pyelogramm enthält oft Jod und kann zu jodinduzierter Hyperthyreose führen

Gynäkologische Anamnese

- **Menstruation:** Sollte letzte Woche sein, ist aber bisher noch nicht eingetreten
- **Wechseljahre:** Laut Gynäkologin noch nicht in den Wechseljahren
- **Kinder:** Eine 28-jährige Tochter (lebt nicht mehr zu Hause)

Familienanamnese

- **Vater (78 Jahre):** Koronare Herzkrankheit (KHK), vor 2 Jahren 2 Stents implantiert, arterielle Hypertonie
- **Mutter (76 Jahre):** Schwere Arthrose in beiden Knien, geht am Rollator
- **Schwester (48 Jahre):** Vor einem Jahr Cholezystektomie

Noxen

- **Nikotin:** Nichtraucherin (wegen Asthma)
- **Alkohol:** 2-3x pro Woche ein Glas Wein
- **Drogen:** Keine

Sozialanamnese

- Verheiratet, lebt mit Ehemann zusammen
- Tochter (28 Jahre) wohnt bereits ausgezogen
- Beruf als Busfahrerin mit viel Stress im Straßenverkehr

Patientenvorstellung durch Nurettin

„Es handelt sich um Frau Patricia Gerber, 46 Jahre alt, geboren am 3. März 1980, 1,72 m groß, aktuell 61 kg schwer. Die Patientin stellte sich vor wegen seit 3 Wochen bestehender Schlafstörungen, innerer Unruhe, Nervosität sowie wässrigem Durchfall.“

Begleitend bestehen Konzentrationsstörungen, Müdigkeit und Tachykardie. Diese Beschwerden haben langsam begonnen.

Die Patientin verneint Atemnot, Haarausfall, Schwellungen am Hals, Schüttelfrost und Bauchschmerzen. Sie gibt an, Fieber abends gemessen zu haben (ca. 38°C) sowie Insomnie aufgrund der Beschwerden. Gewichtsverlust von 5 kg in 3 Wochen trotz gutem Appetit.“

Vorerkrankungen in der Vorstellung

„In der Vorgeschichte besteht seit 10 Jahren eine Hypothyreose, die mit L-Thyroxin 75 µg einmal morgens behandelt wird. Die letzte Kontrolle war vor einem Jahr.“

Außerdem leidet die Patientin unter Asthma bronchiale mit Allergie auf Hausstaub und Pollen (Birke,

Erle), behandelt mit Viani-Spray zweimal täglich."

Operative Anamnese

„Im Alter von 11 Jahren Appendektomie, im Alter von 28 Jahren Sectio, vor 2 Jahren Operation wegen Karpaltunnelsyndrom links."

Familienanamnese in der Vorstellung

„Der Vater der Patientin ist 78 Jahre alt und leidet an KHK (vor 2 Jahren wurden 2 Stents implantiert) sowie arterieller Hypertonie. Die Mutter ist 76 Jahre alt und hat bilaterale Kniearthrose. Die Schwester ist 48 Jahre alt und wurde vor einem Jahr cholezystektomiert."

Reiseanamnese in der Vorstellung

„Vor 2 Monaten war unsere Patientin für 2 Wochen in Thailand. Sie hatte alle Impfungen, aber zur Malariaphylaxe habe ich keine weiteren Informationen."

Verdachtsdiagnose

Hauptverdacht

Hyperthyreose (Verdacht)

Hinweisende Faktoren

- Tachykardie (Puls 90-100/min)
- Gewichtsverlust trotz gutem Appetit
- Nervosität, innere Unruhe, Reizbarkeit
- Schwitzen
- Schlafstörungen
- Durchfall (4-5x täglich)
- Subfebril-febrile Temperaturen

Mögliche Ursachen der Hyperthyreose

- **Jodinduzierte Hyperthyreose:** Nach Kontrastmittelgabe vor 6 Wochen (i.v.-Pyelogramm)
- **Hyperthyreosis factitia:** Möglicherweise zu hohe Dosierung von L-Thyroxin (letzte Kontrolle vor einem Jahr)

Differentialdiagnosen

Kritisch: Malaria muss ausgeschlossen werden!

- **Malaria:** Aufgrund Reiseanamnese (Thailand vor 2 Monaten), keine Prophylaxe, Diarrhö 4-5x täglich, Temperaturen um 38°C
- **Gastrointestinale Infektion:** Nach Tropenreise, pathogene Keime

Geplante Diagnostik

Labor

- Schilddrüsenwerte: TSH (erwartet niedrig), fT3, fT4 (erwartet erhöht)
- **Dicker Tropfen:** Zum Malaria-Ausschluss
- Entzündungsparameter (CRP, Leukozyten)
- Kleines Blutbild

Stuhl Diagnostik

- Stuhl auf pathogene Keime (besonders bei Rückkehrern aus Thailand)

Körperliche Untersuchung

- Inspektion, Palpation, Auskultation
 - Schilddrüsenpalpation
 - Vitalparameter
-

Heikos Feedback und wichtige Hinweise zur Patientenvorstellung
Positive Rückmeldungen

„Sie haben das trotzdem gut gemacht. Vielen Dank.“

„Ich hätte für eine Prüfung gar keine Bedenken bei Ihnen. Ich kann Sie gut verstehen, Sie können sich gut ausdrücken.“

„Der Schwerpunkt liegt sicherlich Richtung Schilddrüse. Da stimme ich Ihnen zu.“

Kritische Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge

1. Reiseanamnese nicht vergessen!

Heikos wichtigster Hinweis: „Bedenken Sie bitte die Reiseanamnese, dass Sie nicht eventuell eine Malaria übersehen!“

„Aber Sie müssen an Malaria denken. Differentialdiagnostisch würde ich immer an eine Malaria denken, Sie zumindest ausschließen.“

„Die Patientin ist vor 2 Monaten, 2 Wochen, in Thailand gewesen. Sie haben nach Impfungen gefragt, aber man müsste wahrscheinlich noch fragen: Haben Sie eine Malariaprophylaxe betrieben?“

2. Zeitfenster bei Tropenreisen beachten

„Alle, jede Diarrhö, die in so einem Zeitraum auch noch später auftritt nach Tropen und Reiserückkehrern, muss man zumindest eine Malaria ausschließen. Das muss man machen.“

3. Beide Diagnosen können gleichzeitig vorliegen

„Auch wenn die klinischen Symptome alle auf eine Hyperthyreose hindeuten - das war eine kleine Falle - ich glaube schon, dass die Hauptdiagnose Verdacht auf Hyperthyreose ist.“

„Aber die Patientin kann ja eventuell beides haben. Sie kann ja auch eine Malaria haben. 4 bis 5x Diarrhö am Tag mit so Temperaturen um 38 Grad. Es muss nicht immer Fieber sein.“

„Sie messen vielleicht im Blut dann ein niedriges TSH und hohe fT3, fT4-Werte, was für eine Hyperthyreose spricht. Aber die Patientin kann ja eventuell beides haben.“

4. Stuhl Diagnostik nicht vergessen

„Natürlich muss man, ich sehe hier unten, gerade wenn eine Diarrhö da ist in der Häufigkeit - sie ist zwar nicht blutig, sie macht keine Schmerzen - aber man muss natürlich den Stuhl auch auf pathogene Keime untersuchen. Das ist völlig klar.“

„Gerade bei Rückkehrern aus Thailand zum Beispiel. Das ist, denke ich, dann in der Klinik auch selbstverständlich: Stuhl auf pathogene Keime.“

5. Dicker Tropfen obligat bei Malaria-Verdacht

„Dicker Tropfen bezüglich Malaria.“

6. Formulierung einfach halten

„Machen Sie es bitte in der Formulierung der Sätze immer einfach.“

Zusammenfassung der diagnostischen Strategie

„Aber Schwerpunkt sicherlich Richtung Schilddrüse. Da stimme ich Ihnen zu, aber bitte die anderen Dinge nicht aus den Augen verlieren.“

Therapieplan

Bei bestätigter Hyperthyreose

- Ursachenabklärung (jodinduziert vs. Überdosierung L-Thyroxin)

- Dosisanpassung L-Thyroxin falls erforderlich
- Ggf. thyreostatische Therapie
- Engmaschige Kontrollen der Schilddrüsenwerte

Bei Malaria

- Sofortige Behandlung mit Antimalariamedikamenten
- Stationäre Überwachung

Symptomatische Maßnahmen

- Rehydratation bei Diarrhö
- Elektrolytausgleich
- Ggf. Antidiarrhoika

Nächste Schritte

- ☐ Körperliche Untersuchung durchführen
- ☐ Laborwerte abwarten (TSH, fT3, fT4)
- ☐ Dicker Tropfen auf Malaria
- ☐ Stuhluntersuchung auf pathogene Keime
- ☐ Befundbesprechung mit Patientin
- ☐ Je nach Ergebnis: Therapieeinleitung

Wichtige Lernlektion aus diesem Fall: Bei Patienten mit Reiseanamnese in tropische Gebiete und unspezifischen Symptomen wie Diarrhö und subfebrilen Temperaturen muss **immer** an Malaria gedacht und diese ausgeschlossen werden - auch wenn eine andere Diagnose (hier Hyperthyreose) klinisch wahrscheinlicher erscheint. Beide Erkrankungen können gleichzeitig vorliegen!